

AIDE-MÉMOIRE
PREMIER RÉPONDANT
MÉDICAL



Ambulance Saint-Jean

Québec

Édition février 2023

NUMÉROS UTILES

Ambulance – Police – Pompiers : 911

Info santé – Info sociale : 811

Centre antipoison : 1 (800) 463-5060

Ressources communautaires : 211

Ambulance Saint-Jean : 1 (800) 706-6660

Contact d'urgence : _____

Responsable ASJ : _____

Cet aide-mémoire appartient à

Nom : _____

No provincial : _____





PCSU

1. Examen des lieux
2. Évaluation primaire
3. Évaluation secondaire
4. Continuité des soins

1. EXAMEN DES LIEUX

- Nature de l'intervention : médical ou trauma
- Évaluer les dangers → **Protection**
- Nombre de blessé(s) → **Renfort au besoin**
- Mécanisme de blessure → **Protect. spinale**
- Besoin(s) particulier(s) → **Police, Pompiers**
- S'identifier et obtenir le consentement
- Degré de conscience : **A-V-P-U (AVDI)**

SI URGENCE → 911

DEGRÉ DE CONSCIENCE

Le degré de conscience évalue la capacité de la victime à réagir aux stimulus externes

A	ALERT Yeux ouverts et visiblement conscient	ALERTE	A
V	VERBAL Somnolent et doit être stimulé verbalement	VERBAL	V
P	PAIN Réagit uniquement à une stimulation douloureuse	DOULEUR	D
U	UNRESPONSIVE Ne réagit pas à aucune stimulation	INCONSCIENT	I





2.ÉVALUATION PRIMAIRE

C

- Arrêter saignements importants seulement
- Inconscient : **911** + prise pouls carotidien
Si pouls absent ou incertain → RCR

A

Airway / Voies respiratoires

- Ouvrir et dégager
- Sang, objet, sécrétion, œdème
- Stridor = obstruction dans les VR

B

Breathing / Respiration

- Qualifier la respiration
 - Fréquence, régularité, amplitude

C

Circulation

- Conscient : prise de pouls radial
 - Fréquence, régularité, amplitude
- État de la peau
 - Coloration, température, texture

D

Désordre neurologique

- Orientation
 - Identité, temps, lieux (3 sphères)

E

Exposer / Examen corps (30 sec)

- Déceler hémorragie interne et déformation
- Rechercher dispositif d'alerte médical
- Retirer de l'environnement chaud ou froid
- Appliquer une couverture, au besoin

3.ÉVALUATION SECONDAIRE

HISTORIQUE

S	Signes et symptômes
A	Allergies
M	Médicaments (suppléments, produits naturels)
M	Maladies antérieures
D	Dernière prise (repas, hydratation, alcool, drogue)
E	Événement déclencheur

* Un SAMMDE par victime

O	Début (Onset) Début soudain ou graduel?
P	Provocation Qu'est-ce qui soulage/exacerbe?
Q	Qualité Quel mot décrit bien votre douleur?
R	Région Où se situe la douleur? Irradie-t-elle?
S	Sévérité Échelle 0 à 10
T	Temps Depuis combien de temps?

* Un OPQRST par symptôme





SIGNES VITAUX

Âge	Fréquence respiratoire	Pouls	TA systolique
Adulte	12-20	60-100	100-140
6 à 12	18-25	75-120	95-115
1 à 6	20-40	80-140	85-115
< 1	30-55	100-190	70-105
N-Né	30-60	100-205	60-80

Saturation en oxygène (SpO₂)

Normale : 94-100 %

MPOC : 88-92 %



6 mm

Glycémie capillaire

Normale : 4.0-7.0 mmol/L



5 mm

Température

Hypothermie : < 35 °C / 95 °F

Normale : 35-38 °C

Fièvre : > 38 °C / 100.4 °F



4 mm

Taille des pupilles

Myosis : ≤ 2 mm

Normale : 3-4 mm

Mydriase : ≥ 5 mm



3 mm



2 mm

État de la peau

Chaude, rosée et sèche



1 mm

ÉCHELLE DE GLASGOW (GCS)

Prioriser l'échelle AVPU (AVDI). Utiliser GCS lorsque plus de précision nécessaire (trauma crânien, AVC, etc.)

Notez la **meilleure** réponse pour chaque catégorie

OUVERTURE DES YEUX

- 4 Spontanée
- 3 À la parole
- 2 À la douleur
- 1 Aucune ouverture

RÉPONSE VERBALE

- 5 Orientée X3
- 4 Conversation confuse
- 3 Mots inappropriés
- 2 Sons incompréhensibles
- 1 Aucune réponse audible

RÉPONSE MOTRICE

- 6 Obéit aux ordres
- 5 Localise la douleur
- 4 Se retire à la douleur
- 3 Flexion du bras
- 2 Extension du bras
- 1 Pas de mouvement

TOTAL

Y __ + V __ + M __ = /15





4. CONTINUITÉ DES SOINS

Réexaminer continuellement l'état de la victime et l'efficacité des soins administrés afin de la maintenir dans le meilleur état possible

- **ABC et signes vitaux**
 - **Stable** : aux 15 min
 - **Instable** : aux 5 min
- **Poursuivre soin(s) pour état de choc**, si applicable
 - Traiter la cause de l'état de choc
 - Prévenir la perte de chaleur corporelle
 - **Normotendu** : positionner selon confort
 - **Hypotendu** : décubitus dorsal, si toléré
- **Valider l'efficacité des traitements** en cours
- **Continuer à soutenir les blessures**, si applicable
 - Attelle : revérifier circulation, motricité et sensibilité
- **Noter l'évolution de la victime + soins administrés**
- **Préparer le transfert d'information** aux paramédics
- **Sécuriser les effets personnels** de la victime

DÉTÉRIORATION → REFAIRE 911

RAPPORT VERBAL

S

Situation

- Nom, sexe, âge
- Plainte principale

B

Background / Antécédents

- Antécédents médicaux
- Médicaments
- Résumé de l'histoire

A

Assessment / Évaluation

- Résultat de l'examen physique
- Signes vitaux
- Soins administré(s) et évolution
- Inquiétude envers la victime?

R

Recommandation

- Répéter raison demande d'aide
- Toute information pertinente





DVR – RA – RCR

OBSTRUCTION GRAVE DES VR

	Nourrisson	Enfant / Adulte
Conscient	 5 tapes dos + 5 poussées thoraciques 	 5 tapes dos + 5 poussées abdominales 
* Enceinte / corpulent : poussées thoraciques		
Inconscient	RCR (30:2) + Regarder dans la bouche avant les 2 ventilations	

RESP. ARTIFICIELLE/ASSISTÉE

Pédiatrie FR < 10/min	Adulte FR < 8/min
1 ventilation aux 2 à 3 sec	1 ventilation aux 6 sec

Vérifier le pouls à toutes les 2 min (**haut risque d'ACR**)

RCR (ratio compressions : insufflations)

Secouriste	Nourrisson / Enfant	Adulte
Seul	30 : 2	30 : 2
2 ou plus	15 : 2	30 : 2

100 à 120 compressions / min – Changer aux 2 min

APPEL 911 PRIORITAIRE

CANULES

Facilitent le dégagement des voies respiratoires supérieures

NASOPHARYNGÉES



Victime avec altération de l'état de conscience

Mesure :

Pointe du nez
au lobe de l'oreille

Astuce :

Favoriser la 1^{ère} insertion
dans la narine droite

Ne pas insérer si suspicion de fracture crânienne

OROPHARYNGÉES



Victime totalement
inconsciente

Mesure :

Coin de la bouche
au lobe de l'oreille

Retirer si réflexe de vomissement présent





OXYGÉNOTHÉRAPIE

Généralités

$SpO_2 \geq 94\%$: Ne pas administrer d'oxygène

$SpO_2 < 94\%$: Viser saturat. entre 94% et 98%

Si aucune mesure de saturométrie disponible (SpO_2), administrer de l'oxygène à haute concentration en cas de :

- **Convulsions actives**
- **Difficulté respiratoire**
- **Degrés de conscience V-P-U**
- **État de choc**

Utiliser un **masque à haute concentration**, peu importe la valeur de SpO_2 , dans les situations suivantes :

- **Inhalation de substance toxique**
- **Accident de plongée**

Particularité

Chez la clientèle atteinte de **MPOC***, viser le confort et une SpO_2 entre 88% et 92%

* Bronchite chronique et/ou emphysème

OXYGÉNOTHÉRAPIE (suite)

Débit d'oxygène selon l'outil utilisé

Lunettes nasales	1 à 6 L/min
Masque à haute concentration*	10 à 15 L/min
Masque de poche	10 à 15 L/min
Ballon-masque*	10 à 15 L/min

*Ajuster le débit afin de maintenir le réservoir d'oxygène gonflé

SATUROMÉTRIE

Facteurs pouvant fausser la lecture :

- Grande luminosité ambiante
- Mouvements importants
- Mauvaise application du capteur
- Vernis à ongles et faux ongles
- Inhalation de certaines substances (ex. CO)
- Mauvaise perfusion des extrémités
 - État de choc
 - Environnement froid
 - Certaines maladies
 - Certains médicaments

APPELER RAPIDEMENT 911



MÉDICAMENTS

Généralités

- Au Qc, il est légalement autorisé d'administrer l'épinéphrine ou la naloxone à une victime, connue ou non pour ces urgences. Au sein des SAC d'ASJ, l'auto-injecteur/vaporisateur doit être fourni par la victime, l'ASJ ou l'événement.
- Il est interdit de suggérer la prise de tout autre médicament. Cependant, vous êtes autorisés à offrir votre assistance à une victime désirant prendre **ses propres médicaments**.

6 BONS

Bonne personne

Nom et prénom sur l'étiquette

Bon médicament

Nom du médicament, date d'expiration et son aspect

Bonne dose

Doit respecter la posologie ou les critères d'inclusion

Bon moment

Heure fixe ou au besoin? Fréquence? Répétable?

Bonne façon

Avaler? Croquer ? Inhalation? Intranasal? Injectable?

Bonne consignation (documenter)

Heure, médicament, posologie, raison et évolution



GLUCOSE

Critères d'inclusion

ET

- Glycémie < 4 mmol/L
- Alerte et capable d'avaler sécuritairement

Critère d'exclusion

- Victime agitée, confuse, agressive ou avec altération de l'état de conscience

Posologie

Suggérer la prise de 15 à 20g de sucre tel que :

- Solution glucosée (Insta-Glucose^{MD}, Dex4^{MD})
- ½ tasse de jus ou boisson gazeuse
- 5 sachets de sucre blanc dans de l'eau
- 1 c. à soupe miel, sirop d'érable ou confiture
- Bonbons (ex Life Savers^{MD}, Skittles^{MD})

Remesurer la glycémie aux **15 min**

- Si critères toujours présents : répéter 1 fois
- Si persistance après 2 doses : composer 911

Particularités

En présence de signes et symptômes compatibles avec une urgence diabétique, s'il est impossible de mesurer la glycémie, suggérer la prise de sucre.

Lorsque la glycémie est corrigée, encourager la victime à manger un repas contenant des glucides **ET** des protéines afin d'éviter une récurrence de l'hypoglycémie.



ÉPINÉPHRINE

Critères d'inclusion

Contact avec agent causal $\leq$ 4h

ET

- Détresse respiratoire **ou** hypotension

OU

- **2 des 4** présentations suivantes :
 - Urticaire ou angioedème
 - Difficulté respiratoire
 - Défaillance circulatoire
 - Symptômes gastro-intestinaux

Critère d'exclusion

- Aucun

Posologie

Auto-injecteur d'épinéphrine :

$\geq$ 50 kg / 110 lbs : 0,5 mg IM (si disponible)

$\geq$ 25 kg / 55 lbs ($\geq$ 8 ans) : 0,3 mg IM

$<$ 25 kg / 55 lbs ($<$ 8 ans) : 0,15 mg IM

- Répéter aux 5 min si détérioration
- Répéter aux 10 min si présence de critères d'inclusion
- Répéter aux 10 min si absence d'amélioration

Site d'injection : tier médian du vaste externe (cuisse)

APPEL 911 PRIORITAIRE



NALOXONE

Critères d'inclusion

ET

- Suspicion de surdosage aux opioïdes

ET

- Degré de conscience P ou U
- Dépression respiratoire (bradypnée)

Critère d'exclusion

- Anaphylaxie connue à la naloxone
- Convulsions après une administration

Posologie

Vaporisateur nasal NARCAN^{MD} :

1 spray aux 3 min jusqu'à l'obtention d'eupnée

- Insérez doucement la pointe de la buse dans une narine jusqu'à ce que les doigts soient collés sur le nez.
- Changer de vaporisateur et alterner de narine à chaque administration.

Particularité

Débuter la respiration artificielle en priorité si la victime à un pouls, sinon commencer la RCR. Administrer la première dose de naloxone dès que possible.

APPEL 911 PRIORITAIRE



AÉROSOL-DOSEUR

Lors de difficulté respiratoire, plusieurs victimes utilisent un bronchodilatateur à courte action pour soulager leurs symptômes.

La plupart utilisent une pompe bleue contenant du salbutamol (ex Airomir^{MD}, Ventolin^{MD}).

L'utilisation d'un tube d'espacement augmente l'efficacité de l'aérosol-doseur (ex Aerochamber^{MD}).

AVEC TUBE D'ESPACEMENT

1. Agiter l'aérosol-doseur X3-5 sec et retirer le bouchon
2. Insérer l'aérosol-doseur dans le tube d'espacement
3. Expirer complètement
4. Refermer les lèvres autour de l'embout buccal
5. Appuyer une fois sur la cartouche
6. Inspirer lentement et profondément par la bouche
7. Retenir la respiration X5-10 sec
8. Expirer normalement

*Si incapable de retenir son souffle, faire 4-6 cycles respiratoires dans le tube.

SANS TUBE D'ESPACEMENT

1. Agiter l'aérosol-doseur X3-5sec et retirer le bouchon
2. Expirer complètement
3. Refermer les lèvres autour de l'embout buccal
4. Inspirer lentement par la bouche
5. Appuyez une fois sur la cartouche
6. Continuer à inspirer lentement et profondément
7. Retenir la respiration X 5-10 sec
8. Expirer normalement



AVC SUSPECTÉ

Visage affaissé

« Faites un sourire forcé, en montrant les dents »

Un côté du visage ne bouge pas et semble affaissé

Incapacité de lever les bras

« Levez les 2 bras, paumes vers ciel, yeux fermés.

Maintenez cette position pendant 10 secondes »

L'un des bras descend comparativement à l'autre

Trouble de la parole

Faire répéter « Le ciel est bleu à Cincinnati »

Ne prononce pas les mots correctement, utilise des mots inappropriés ou est incapable de parler

Extrême urgence → 911

En attendant l'ambulance

- Mesurer les signes vitaux
- Pas O₂ d'emblée. Respecter protocole SpO₂
- Noter l'heure du début des symptômes
- Garder un proche à proximité, si présent
- Rassurer la victime
- Devrait consult. même si symptôme(s) disparu(s)

APPEL 911 PRIORITAIRE



PROB. CARDIAQUE SUSPECTÉ

Suspecter une urgence cardiovasculaire si la victime présente :

- Douleur thoracique avec ou sans irradiation à la mâchoire, bras ou dos
 - **P**ression / **p**esanteur / constriction
 - **E**touffement / **E**tau
 - **P**oing
 - **S**errement
 - Indigestion / Inconfort
- Difficulté resp. ou faiblesse soudaine
- Signes et symptômes d'état de choc

En attendant l'ambulance

- Mettre la victime au repos, assurer le confort
- Mesurer les signes vitaux
- Pas O₂ d'emblée. Respecter protocole SpO₂
- S'assurer que le DEA est disponible
- Si la victime décide de prendre par **elle-même** sa propre médication (nitro et AAS), offrir de vérifier la présence de critères d'exclusion.

Particularités

Porter une attention particulière aux clientèles avec signes et symptômes moins évidents: femmes, personnes âgées, atteintes de diabète, etc.

APPEL 911 PRIORITAIRE



ACIDE ACÉTYLSALICILIQUE

Critères d'exclusion

- Allergie à l'acide acétylsalicylique
- Contre l'avis de son médecin

Particularités

Le nom commercial de l'acide acétylsalicylique (AAS) est l'Aspirine^{MD}. L'utilisation de comprimé croquable permet une absorption plus rapide du médicament. Respecter la posologie. Ne pas suggérer l'AAS si la victime n'a pas de prescription.

NITROGLYCÉRINE

Critères d'exclusion

- Pression artérielle systolique ≤ 100
- Toute prise <48h de supplément ou médicament pour la dysfonction érectile ou l'hypertension pulmonaire tel que:
 - Sildenafil (ex Viagra^{MD}, Revatio^{MD})
 - Vardenafil (ex Levitra^{MD}, Staxyn^{MD})
 - Tadalafil (ex Cialis^{MD}, Adcirca^{MD})

Particularités

Amorcer la pompe de nitro en pesant une fois sur le piston dans le vide. Ne pas agiter. Administrer sous ou sur la langue. Ne pas avaler. Respecter la posologie. En général, aux 5 à 10 min, max 3 jets.



HYPERTHERMIE

CRAMPES MUSCULAIRES

Contraction musculaire douloureuse, incontrôlable, d'apparition brutale et de courte durée en contexte d'effort.

Premiers soins :

- Mettre la victime au repos dans un endroit frais
- Suggérer une solution de réhydratation, si requis
- Masser et étirer progressivement le muscle atteint

ÉPUISEMENT À LA CHALEUR

Lors de temps chaud, le débit cardiaque ne suffit plus à la demande du corps en raison d'une déshydratation et de la redistribution du sang vers la peau

Présentation clinique :

- Faiblesse et étourdissement
- Céphalée
- Nausées et vomissements
- Crampes musculaires persistantes
- Hypotension orthostatique
- Tachycardie, tachypnée
- **Aucune perte de conscience ou convulsions**
- **Aucune confusion franche**
- **Température corporelle 38-40°C**

Premiers soins :

- Retirer de l'environnement chaud
- Refroidir la victime
- Suggérer une solution de réhydratation



COUP DE CHALEUR

Forme anormale d'hyperthermie provoquant des dommages au cerveau et aux organes. Peut survenir même en l'absence d'activité physique.

MENACE IMMÉDIATEMENT LA SURVIE

Présentation clinique :

- Faiblesse et étourdissement
- Céphalée
- Nausée et vomissement
- Agitation
- Délirium
- Perte de coordination musculaire
- Peau rouge, avec ou sans sueur
- **Perte de conscience ou convulsions**
- **Confusion franche**
- **Température corporelle > 40°C**

Premiers soins :

- Retirer de l'environnement chaud
- Refroidir la victime le plus rapidement possible
 - Immersion dans l'eau froide (tête à l'extérieur)
 - Douche froide
 - Drap mouillé et froid
 - Compresses froides instantanées
 - Ventilateur

Poursuivre les traitements jusqu'à la résolution des symptômes ou l'atteinte d'une température corporelle < 39 °C.

APPEL 911 PRIORITAIRE



HYPOTHERMIE

LÉGÈRE

Température corporelle : 32-35 °C

Présentation clinique :

- Grelottement présent
- Conscient
- Trouble de l'élocution
- Renfermé, indifférent, perte intérêt activité
- Pouls normal
- Respiration normale

MODÉRÉE

Température corporelle : 28-32 °C

Présentation clinique :

- Grelottement violent ou interrompu
- Désorienté, somnolent, irrationnel
- Démarche hésitante, maladroit
- Pouls lent et faible
- Respiration lente et faible

GRAVE

Température corporelle : < 28 °C

Présentation clinique :

- Grelottement interrompu
- Inconscient
- Pouls faible, irrégulier ou absent
- Respiration faible ou absente



SOINS – HYPOTHERMIE

LÉGÈRE

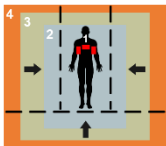
Premiers soins :

- Retirer de l'environnement froid
- Prévenir la perte de chaleur supplémentaire
- Retirer les vêtements mouillés
- Suggérer un chocolat chaud (Ø café ou alcool)
- Compresses chaudes au tronc, si nécessaire

MODÉRÉE ET GRAVE

Premiers soins :

- Garder en position couchée
- Manipuler avec grande précaution
 - Secousse = risque d'arythmie et d'ACR
- Retirer de l'environnement froid
- Prévenir la perte de chaleur supplémentaire
- Couper et retirer les vêtements mouillés
- Aucune nourriture ou breuvage
- Compresses chaudes au niveau du tronc
 - Réchauffer tronc **AVANT** bras et jambes
- Lorsque faisable, faire un « burrito »



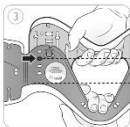
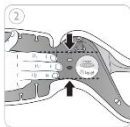
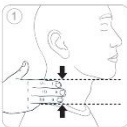
1. Compresses chaudes
2. Pare-vapeur :
 - Toile plastique
 - Couverture de survie
3. Couche thermique :
 - Couverture
 - Sac de couchage
4. Toile isolante de plastique



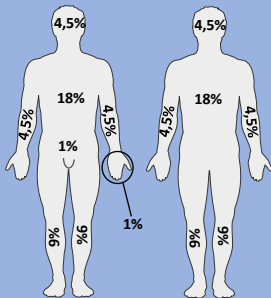
COLLIER CERVICAL

- 1. Maintenir la tête en position neutre**
- 2. Mesurer la taille du collier sur la victime**
 - a. Main ouverte, pouce vers le haut
 - b. Repère inférieur : épaule (trapèze)
 - c. Repère supérieur : menton
- 3. Ajuster le collier et le soutien de menton**
 - a. Reporter le nombre de doigts sur les repères du collier.
 - b. Repère inférieur : bord plastique inférieur
 - c. Repère supérieur : indication de réglage le plus proche du doigt supérieur mesuré
- 4. Verrouiller les onglets**
- 5. Préformer et installer le collier**
 - a. Réajuster si non-toléré, assurer le confort

Ne pas lâcher la tête tant que la victime n'est pas complètement immobilisée sur une planche dorsale ou dans un matelas immobilisateur

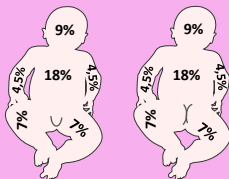


BRÛLURES



Enfant - Adulte

Antérieur - Postérieur



Nourrisson





GARROT

Critères d'utilisation

- Hémorragie importante d'un membre incontrôlable par une pression directe

OU

- Amputation partielle ou totale d'un membre (au-dessus poignet / cheville)

OU

- Hémorragie importante sur une victime requérant des interventions immédiates et prioritaires (RCR, RA, évacuation, etc.)

Sites

Le plus près possible du traumatisme :

4 doigts au-dessus (proximal) de la blessure

2 doigts au-dessus (proximal) d'une articulation

Si 2^e garrot nécessaire, mettre au-dessus du 1^{er}

Particularités

Appliquer directement sur la peau, si possible.

Faire un très bon serrement initial.

Laisser le garrot visible, noter l'heure d'application puis transmettre l'information aux paramédics.

Administer les soins continus pour état de choc.

Ne jamais retirer ou desserrer le garrot.

APPEL 911 PRIORITAIRE



TRIAGE - START

MARCHE?

OUI

VERT

NON

RESPIRE?

NON

RESPIRE APRÈS
OUVERTURE DES
VOIES
RESPIRATOIRES?

NON

NOIR

OUI

OUI

FRÉQUENCE
RESPIRATOIRE

PLUS DE 30/MIN

ROUGE

MOINS
30/MIN

POULS RADIAL?

NON

ROUGE

OUI

NON

SUIT DES
CONSIGNES
SIMPLES?

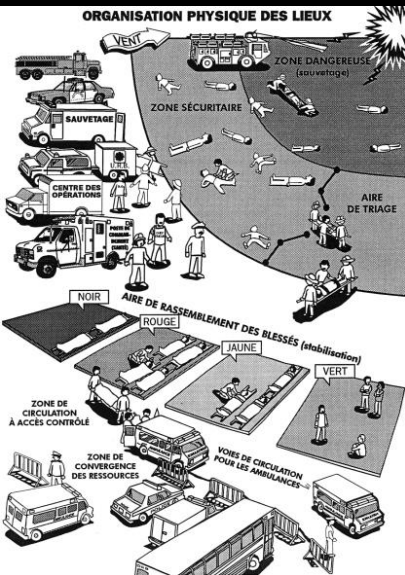
OUI

JAUNE



SINISTRE

ORGANISATION PHYSIQUE DES LIEUX





NOTES AUX LECTEURS

Cet aide-mémoire est produit par l'équipe de formation provinciale des services à la collectivité d'Ambulance Saint-Jean, Conseil du Québec. Nous remercions tous les employés et bénévoles y ayant contribué.

Cet aide-mémoire ne constitue pas un document protocolaire officiel. Il s'agit d'une référence pour aider les secouristes de l'ASJ en service. Ces derniers doivent toujours respecter les normes et procédures enseignées lors de leurs formations.

N'hésitez pas à contacter l'équipe de formation pour tout commentaire ou question.

© Reproduction interdite.

Si vous trouvez cet aide-mémoire, contactez :

Ambulance Saint-Jean
1 800 706-6660
qc.info@sja.ca

10-110 Boulevard Crémazie O,
Montréal (Qc) H2P 1B9

